FilmArray®消化管パネル検査が診断補助に有用であった赤痢アメーバ性腸炎の 1 症例

◎宮下 大地[1)]、上地 幸平[1)]、大谷 初美[1)]、東 友子[1)]、大谷 洸樹[1)]、山﨑 大翔[1)]、前河 晶子[1)]、中出 祐介[1)]
金沢大学附属病院[1)]

【はじめに】

赤痢アメーバ（*Entamoeba histolytica*）性腸炎の診断には、糞便中からの虫体検出や血清抗体検査が用いられるが、いずれも検出感度や結果報告までの時間に課題がある。近年では多種類の消化管病原体を網羅的に検出できる FilmArray®消化管パネル検査が診断補助ツールとして注目されている。今回、SLE 患者において FilmArray®消化管パネル検査が赤痢アメーバ性腸炎の診断に有用であった症例を経験した。

【症例】

50 歳代女性。SLE の既往あり。3 年前に赤痢アメーバ性腸炎の治療歴あり。X-7 日頃より右下腹部痛が出現し増悪したため、X 日に精査加療目的で当院に入院となった。X+3 日に下部消化管内視鏡検査を施行し回盲部から上行結腸に多発潰瘍を認め、生検組織の PAS 染色で赤痢アメーバを疑う構造物を認めた。糞便検体を用いて直接塗抹ならびに MGL 法による検査を実施したが栄養体及びシストは検出されなかった。感染症科の依頼により残余検体を用いて FilmArray® 消化管パネル検査を実施したところ *E. histolytica* が検出された。メトロニダゾールとパロモマイシンによる駆虫を施行した。治療により症状、炎症所見および画像所見は改善し退院となった。

【考察】

赤痢アメーバ性腸炎における糞便中の虫体検出、特に栄養体の検出には検体採取後、速やかな検査実施が求められる。本症例では虫体検出は陰性であったが、FilmArray®消化管パネル検査により *E. histolytica* が検出され補助診断として有用であった。検査結果の信頼性には検体の採取・保存・運搬を含めた検査前プロセスが大きく影響する。迅速かつ正確な診断には適切な検査法の選択に加えて、検査プロセスの管理と検査室と臨床側の密接な連携が重要かつ不可欠であると考えられた。

金沢大学附属病院検査部 – 076-265-2000 (代表)